

— THAILAND ・ INSURANCE ・ 2027

超高齢社会の転換点に立つタイ保険市場

人口動態の転換が、生命・健康保障の需要曲線を書き換えている。ヘルスライダー、年金保険、そして保障格差が2027年の機会を規定する。

COUNTRY

タイ

SECTOR

保険

PUBLISHED

2026年5月

HORIZON

2027-2032

本分析の構築方法

本レポートは、規制当局の開示情報、業界団体統計、人口動態予測、および事業者の財務情報を三角検証し、タイ保険市場の先行きを読み解いたものです。すべての定量的主張にはインライン出典タグを付与しており、**【Kira estimates】**は当社の独自分析から導いた数値を示します。

PRIMARY INPUTS

→ 規制・業界団体データ

保険委員会（OIC）指令、タイ生命保険協会およびタイ損害保険協会の収入保険料統計、上場保険会社の開示資料。

→ 人口動態・医療制度の分析

高齢化進展予測、国民皆保険（UCS）利用実態調査、および需要仮説の根拠となる国民医療費系列データ。

→ アナリスト三角検証

公表数値に乖離がある場合、当社チームが最も妥当な中間値に収斂させ、KIRA推計としてタグを付与します。

SCOPE & LIMITS

→ 分析対象

人口動態転換の観点から捉えたタイ国内保険市場（生命・損害保険）。再保険およびオフショアキャプティブは対象外です。

→ 通貨・換算

タイバーツ（THB）は届出値で記載。USD換算はTHB 34.5/USD を使用し、方向感を示す参考値です。

→ 予測の考え方

将来数値は確定予測ではなく、記録済みの基準年に固定した方向性シナリオです。レンジ表示は実質的な不確実性を反映しています。

目次

04	エグゼクティブサマリー 市場の現状、人口動態仮説、および5つの戦略的示唆	PG 04
06	人口動態転換 高齢社会から超高齢社会へ ― 需要のエンジン	PG 07
07	健康保障格差 公的保障の限界と民間補完の起点	PG 08
08	市場規模と商品構成 種目別収入保険料。ヘルスライダーと年金保険が牽引	PG 09
10	競争構造 上位生命保険会社とリーダーのプロファイル	PG 11
13	規制とコスト抑制の転換 コペイメント、RBC、IFRS 17の影響	PG 14
15	テクノロジーとAI：募集・保険金支払いの変革 引受、不正検知、チャネル経済性	PG 16
17	2032年展望と出典 シナリオ、収入保険料軌跡、調査方法論後記	PG 17

タイ保険市場 — 人口動態による再評価

USD 310億の収入保険料プールに、超高齢社会入りを目前にした人口動態が重なる。ヘッドライン成長は一桁台にとどまるが、商品構成はヘルスライダー、年金保険、老後連動型保障へと決定的にシフトしている。今後24ヶ月が、高齢顧客を取り込む事業者を決定づける。

業界収入保険料 2024年

941 THB bn

前年比+2.4% [TLAA-OIC 2024]

TLAA-OIC

医療・CI保険料 2024年

125 THB bn

+13.7%、全体の19.1% [TLAA 2024]

TLAA

60歳以上人口比率 2024年

20 %

1,360万人 [GISTDA 2025]

GISTDA

医療費自己負担比率

11.3 %

民間保障の構造的格差

UHC STUDY

市場の現状

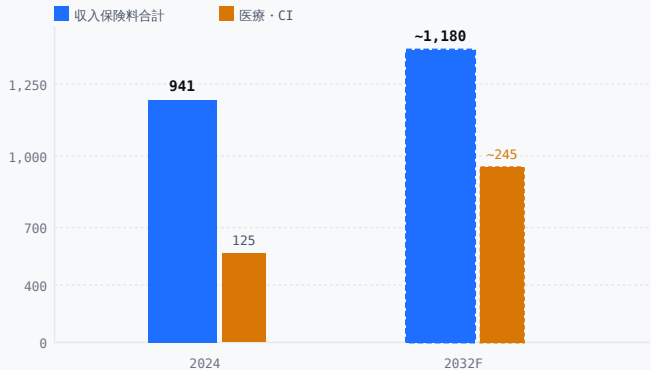
タイの保険会社は**2024年に収入保険料THB 9,410億**を計上し、前年比**2.4%増**[TLAA-OIC 2024]となりました。生命保険はTHB 6,540億 (+3.2%) [TLAA 2024]、損害保険はTHB 2,860億 (+0.5%) [TGIA 2024]です。ヘッドライン成長は一桁台ですが、構成は急速に変化しており、医療・重篤疾病保険料は**13.7%増のTHB 1,250億**へ急伸し、**生命保険料の19.1%**を占めるに至っています[TLAA 2024]。

なぜ今か：需要エンジンとしての人口動態

60歳以上の人口は**2024年に1,360万人（全人口の20%）**に達し[GISTDA 2025]、子ども（15歳未満）の数を初めて上回りました。2035年までには60歳以上が28%に達する「超高齢社会」入りが見込まれます[WHO 2024]。自己負担が医療費の11.3%を占め[UHC Study 2024]、医療インフレが年率8～10%で推移する中[Bangkok Post 2024]、公的制度が現状維持の間、民間の保障格差は毎年拡大し続けます。

収入保険料プールとヘルスライダー構成比の変化

タイ ・ THB BN ・ 2024年実績 ・ 2032年予測



SOURCE: TLAA, OIC, KIRA TRIANGULATION ・ FORECAST = KIRA ESTIMATE ANCHORED TO 2024 BASE ・ KIRA RESEARCH 2026

出典凡例 ・ GISTDA 2025 = Geo-Informatics & Space Technology Development Agency population analysis 2025 ・ TGIA 2024 = Thai General Insurance Association direct-premium statistics 2024 ・ TLAA 2024 = Thai Life Assurance Association annual statistics 2024 ・ TLAA-OIC 2024 = TLAA & Office of Insurance Commission combined industry total 2024 ・ UHC Study 2024 = Universal Coverage Scheme out-of-pocket study 2024 ・ WHO 2024 = WHO South-East Asia healthy-ageing feature 2024 ・ Bangkok Post 2024 = Bangkok Post insurer medical-inflation report 2024 ・ Kira estimates = KIRA in-house analyst triangulation

市場参加者に向けた5つの戦略的示唆

2032年に向けた競争力学を再編する5つの力。いずれも記録済みの市場データと、タイの人口動態・規制軌跡に関する当社の分析に基づいています。

01 ・ DEMAND

高齢顧客のライフサイクル全体を取り込む

60歳以上が**全人口の20%から2035年には28%へ上昇**する中[GISTDA 2025][WHO 2024]、勝者は医療・年金・介護を1つの顧客関係でバンドルする事業者です。2027年の価値創出を牽引するのは新規顧客獲得数ではなく、クロスセル深度です。

Anchor: **1,360万人** (60歳以上、2024年)

02 ・ HEALTH GAP

保障格差が成長の源泉

公的保障は人口の74%をカバーする[Frontiers 2024]一方、自己負担は医療費の11.3%に達しています[UHC Study 2024]。医療・重篤疾病保険料はすでに**年率13.7%で成長**しています[TLAA 2024]。中間層の保障格差を解消することが、最大の有機的成長機会です。

Anchor: **19.1%** (医療保険の生命保険料比率)

03 ・ COST CONTROL

コペイメントが医療経済を再設定する

2025年3月19日付けで施行されたOICコペイメント条項[OIC 2025]は、年率8〜10%の医療インフレを抑制するため[Bangkok Post 2024]、請求コストを契約者と分担する仕組みです。コペイメントを適切に価格設定・説明できる事業者は損害率を守り、対応が遅れた事業者は逆選択にさらされます。

Anchor: **8〜10%** (年間医療インフレ率)

04 ・ CAPITAL

IFRS 17とRBCは大規模事業者の貸借対照表に有利

リスクベース資本 (RBC) とIFRS 17は長期保証のコストを引き上げます[OIC 2025]。年金保険を多く抱える事業者には厳密なALMが求められます。**規模の小さい保険会社**は上位3社に対し構造的な資本劣位に置かれており、選択的な業界再編が見込まれます。

Anchor: 上位3社が**〜53%**の生命保険料を占有

05 ・ DIGITAL

AIはパイロットから引受の中核へ

AI引受、保険金請求自動化、不正検知モデル — 先進的な導入例では不正請求を**最大〜30%削減**しています[InsurTech 2025] — は2027年には業界標準となります。バンカシュアランスと代理店チャネルは高齢顧客の信頼チャネルとして残存し、デジタルはこれを補完します。

Anchor: **〜30%** (不正請求削減率)

出典凡例 ・ Frontiers 2024 = Frontiers in Public Health, low use of Thailand's Universal Coverage Scheme 2024 ・ GISTDA 2025 = GISTDA population analysis 2025 ・ InsurTech 2025 = InsurTech Digital AI claims & underwriting review 2025 ・ OIC 2025 = Office of Insurance Commission 2025 directives (copayment, RBC, IFRS 17) ・ TLAA 2024 = Thai Life Assurance Association statistics 2024 ・ UHC Study 2024 = Universal Coverage Scheme out-of-pocket study 2024 ・ WHO 2024 = WHO South-East Asia healthy-ageing feature 2024 ・ Bangkok Post 2024 = Bangkok Post medical-inflation report 2024

SECTION 06

人口動態の転換

タイは同所得水準のどの国よりも速いペースで高齢化している。60歳以上の人口は**2024年に全人口の20%を超え**、2035年には28%に達する見通し — 超高齢社会の到来だ。これは保険業界の背景要因ではない。**それ自体が本質的なテーマ**である。

6.1 年齢構造

6.2 超高齢社会への軌跡

6.3 地域間格差

6.4 需要への影響

高齢社会から超高齢社会へ：保障需要を牽引するエンジン

60歳以上のタイ人の比率は2000年の10%から**2020～2024年の20%へ倍増**[World Bank 2023][GISTDA 2025]し、2050年には36%に達すると予測されます。1ポイントの上昇ごとに、需要は蓄積型商品から医療・年金・介護へとシフトします。

逆転した年齢ピラミッド

2024年に60歳以上の人口は**1,360万人に達し、15歳未満の950万人を上回りました**[GISTDA 2025]。縮小する生産年齢人口が増加する高齢扶養層を支える ― タイでは地域の競合国よりも早くこの典型的な高齢化社会の構造圧力が到来しています。

超高齢社会の閾値

WHOはタイが**2035年**までに60歳以上28%の「超高齢社会」入りすると予測しています[WHO 2024]。2050年には人口の約36%が60歳以上になります[World Bank 2023]。長寿化は保険会社が引き受ける医療・介護債務の期間を長期化させます。

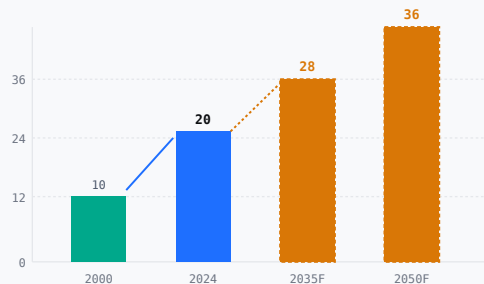
地域間格差

北部、中部、東北部はすでに最高水準の高齢化指数を示しており[GISTDA 2025]、出生率の低下と生産年齢層の流出が背景にあります。地方のミクロ市場ごとに成熟速度が異なり、農村部での販売網投資の回収時期に影響します。

60歳以上人口比率の推移

% 60+

タイ ・ % OF POPULATION ・ 2000-2050F



SOURCE: WORLD BANK, GISTDA, WHO ・ KIRA ANALYSIS ・ KIRA RESEARCH 2026

15歳未満人口 2024年

9.5 m

60歳以上を下回る

GISTDA

超高齢社会突入年

2035

60歳以上28% [WHO 2024]

WHO

60歳以上比率 2050年

36 %

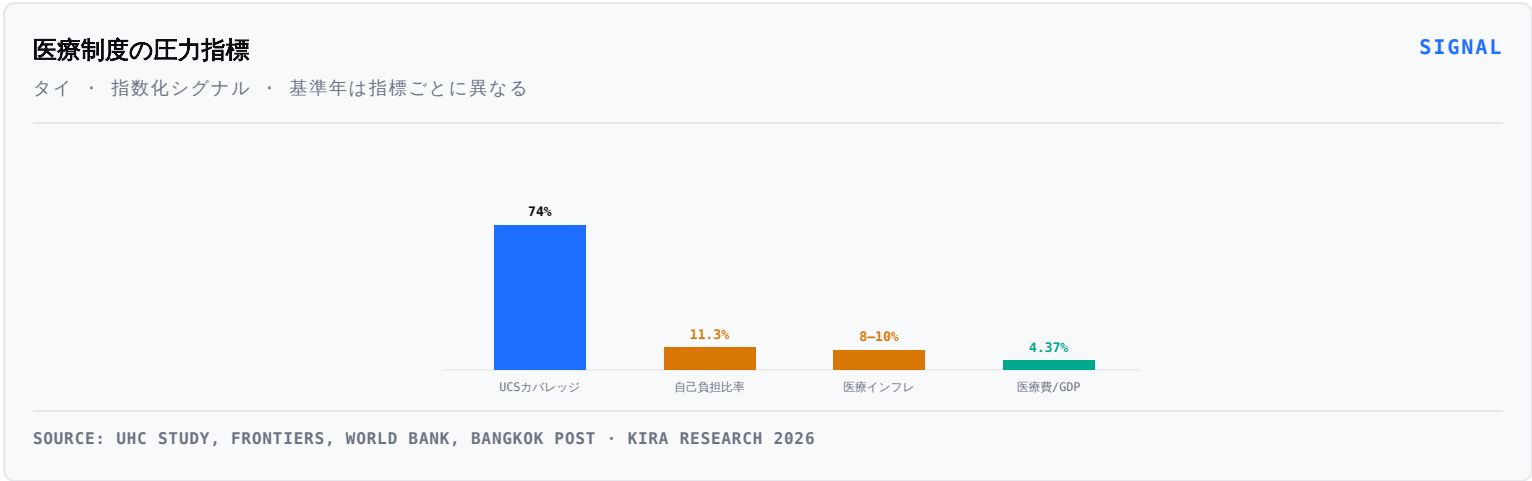
2000年の10%から上昇

WORLD BANK

出典凡例 ・ GISTDA 2025 = GISTDA population analysis 2025 ・ WHO 2024 = WHO South-East Asia healthy-ageing feature 2024 ・ World Bank 2023 = World Bank, Caring for Thailand's Aging Population 2023

公的保障の限界と民間補完の起点

タイの税財源による国民皆保険（UCS）は真の成果ですが、カバレッジの広さは深さと同義ではありません。人口が高齢化し医療費が一般インフレを上回る中、**民間健康保障格差**が決定的な商業機会となっています。



SIGNAL

カバレッジの広さ vs. 深さ

UCSは人口の約**74%**をカバーする[Frontiers 2024]一方、予算が医療コストに追いつかず、民間医療機関への移行により自己負担は**医療費の11.3%**に達しています[UHC Study 2024]。

UCS対象人口	~ 74%
自己負担比率	11.3%
医療費/GDP（2023年）	4.37%
医療インフレ	8-10%

なぜ格差は拡大するのか

医療費はGDPの**4.37%（2023年）** から2028年には~4.49%へ緩やかに上昇する見通しで[World Bank 2023]、保健省の総医療費5%上限の枠内にとどまっています。しかし要介護高齢者の長期介護コストは**2040年にTHB 5,000億に達する**と予測され、高齢者医療費は2032年までに3倍になる見込みです[NER 2024]。財政的な枠組みだけでは高齢化の曲線を吸収できません。

商業的な解釈

中間層はすでに、基本的な公的医療と自身が期待する水準（個室、迅速なアクセス、慢性疾患管理）の差額を自己負担しています。これはまさにヘルスライダーや単独医療保険が取り込む需要であり、このセグメントで**収入保険料が13.7%成長**している理由です[TLAA 2024]。保障格差は嘆くべき市場の失敗ではなく、責任ある形で引き受けるべき成長可能残高です。

出典凡例 ・ Frontiers 2024 = Frontiers in Public Health, low use of UCS 2024 ・ NER 2024 = Development Economic Review, future health expenditure & long-term care 2024 ・ TLAA 2024 = Thai Life Assurance Association statistics 2024 ・ UHC Study 2024 = Universal Coverage Scheme out-of-pocket study 2024 ・ World Bank 2023 = World Bank Thailand ageing & expenditure 2023

種目別収入保険料：ヘルスライダーと年金保険が構成を牽引

生命保険が保険料プールを支配しているが、成長は保障・老後商品に集中している。終身蓄積型は成熟段階にあり、ヘルスライダー、重篤疾病、年金保険が2027年に向けて人口動態の追い風を受けます。

生命保険がリード、損害保険は安定

生命保険料**THB 6,540億 (+3.2%)** は損害保険のTHB 2,860億 (+0.5%) を大きく上回ります[TLAA 2024][TGIA 2024]。損害保険内では、医療保険が2025年上半期に24%増と際立った伸びを見せた一方、自動車は2%増にとどまり[TGIA 2025]、両種目にわたって高齢化シグナルが表れています。

ライダーと年金保険が成長エンジン

終身保険は生命保険収入保険料の約60%を占めますが、付帯特約が**22.3%のシェア**を持ち、より速いペースで成長しています[GlobalData 2025]。医療・CI特約は2028年まで5.4% CAGRで成長予測[GlobalData 2025]。90〜99歳払の年金保険は超高齢社会に対する自然な老後収入の解答です[Muang Thai 2025]。

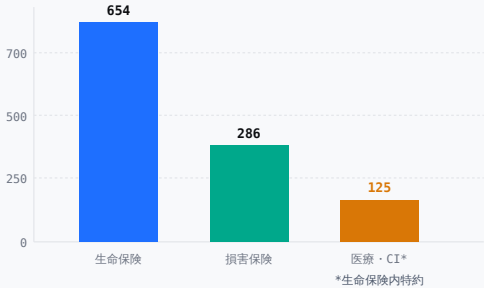
USDフレーム

市場全体は**2024年に約USD 310億**で、4.1% CAGRで2029年までにUSD 380億に達すると予測[Statista 2025]。生命保険単体では2028年までにUSD 230億へ成長見込みです[GlobalData 2025]。

2024年収入保険料の種目別内訳

THB BN

タイ ・ THB BN ・ 生命 VS 損害 VS 医療CI



SOURCE: TLAA, TGIA, GLOBALDATA, STATISTA ・ KIRA ANALYSIS ・ KIRA RESEARCH 2026

生命保険料 2024年

654 THB bn

前年比+3.2% [TLAA 2024]

TLAA

損害医療 2025年上半期

+24%

損害保険最速成長種目 [TGIA 2025]

TGIA

2029年市場規模

38 USD bn

4.1% CAGR [Statista 2025]

STATISTA

出典凡例 ・ GlobalData 2025 = GlobalData Thailand life insurance market analysis 2025 ・ Muang Thai 2025 = Muang Thai Life annuity product disclosures 2025 ・ Statista 2025 = Statista Thailand insurance market forecast 2025 ・ TGIA 2024 = Thai General Insurance Association statistics 2024 ・ TGIA 2025 = Thai General Insurance Association H1 2025 update ・ TLAA 2024 = Thai Life Assurance Association statistics 2024

SECTION 10

競争構造

タイの生命保険は規模のゲームだ。上位3社 — **AIA**、**FWD**、**タイライフ** — は保険料の半数以上を書き、人口動態のシフトは加齢ライフサイクル全体をカバーする貸借対照表の厚み、販売信頼、商品幅を持つ事業者を有利にする。

10.1 市場シェア

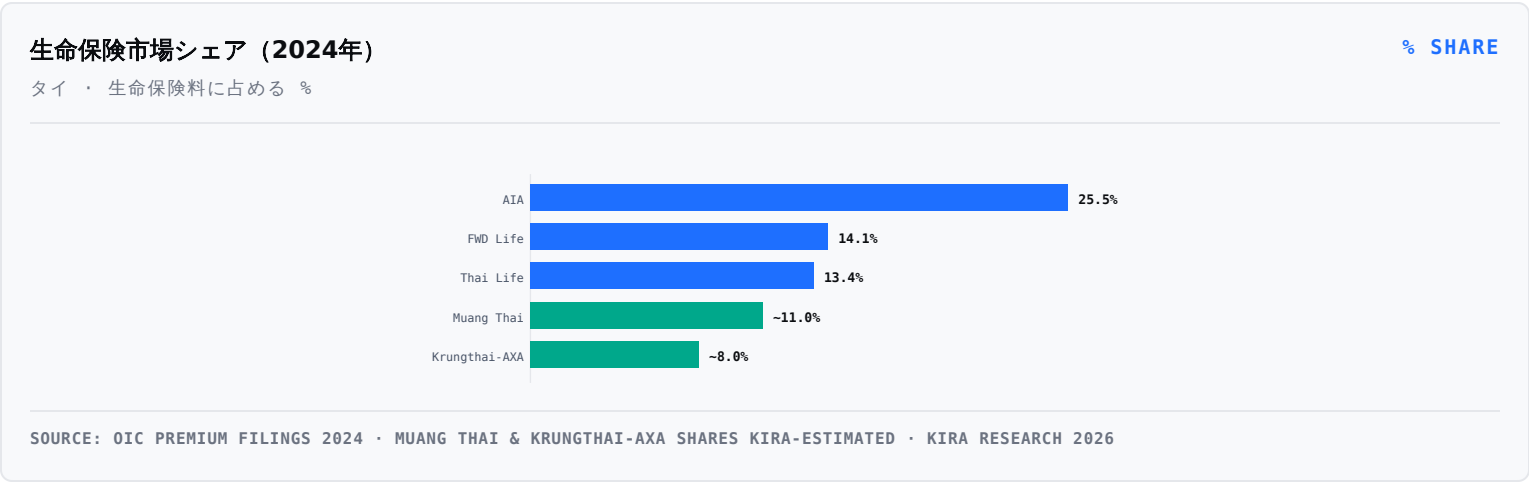
10.2 上位5社

10.3 リーダープロフィール

10.4 販売チャネル

市場構造：集約化・外資主導・スケール競争

上位3生命保険会社が収入保険料の約**53%**を**支配**しており[OIC 2024]、中程度から高度の集約化構造です。外資系親会社が資本と保険数理の専門性を提供し、人口動態転換はスケール保有者と長尾小規模事業者の差を拡大させます。



規模と親会社

AIAが**25.5% (THB 1,670億)** でトップ、FWDが14.1% (THB 920億)、タイライフが13.4% (THB 880億) [OIC 2024]。外資および銀行系親会社がリーダーの資本力を支えています。

上位3社合計シェア	~53%
AIA保険料	THB 167 bn
FWD保険料	THB 92 bn
ムアンタイ保険料	THB 72 bn

MARKET LEADER RANK 01 AIA Thailand AIA Group（香港） シェア 25.5% 保険料 THB 167 bn チャネル 代理店主体 強み：最大規模の専属代理店、医療・保障重視、地域全体の貸借対照表の厚み。	RANK 02 FWD Life Insurance FWD Group（汎アジア系） シェア 14.1% 保険料 THB 92 bn チャネル バンカ + デジタル 強み：デジタルファーストのブランド、強力なバンカシュアランス、急成長する保障ビジネス。	RANK 03 Thai Life Insurance 国内上場（SET: TLI） シェア 13.4% 保険料 THB 88 bn チャネル 代理店主体 強み：国内ブランドの厚み、高齢者向け商品、上場企業としての情報開示。	RANK 04 Muang Thai Life ムアンタイグループ / Ageas提携 保険料 THB 72 bn 注力領域 年金・老後 チャネル バンカ（カシコン銀行） 強み：老後商品の深さ（99歳払年金）、強力な銀行系販売網。
--	---	--	---

AIA Thailand

AIA Groupの子会社・香港上場の汎アジア系保険会社

MARKET LEADER

HEALTH & PROTECTION

KIRA TIER 1

生命保険シェア

25.5 %

収入保険料

167 THB bn

主要チャネル

代理店

親会社

AIA Grp

市場ポジション

AIAはタイ生命保険の明確なリーダーであり、**2024年にTHB 1,670億・保険料シェア25.5%**を計上[OIC 2024] ― 第2位の2倍近い規模です。この強さは国内最大規模の専属代理店網と、純粋な貯蓄商品よりも医療・保障に長年注力してきた姿勢に支えられています。

なぜ高齢顧客を取り込めるか

ヘルスライダー、重篤疾病、シニア生命保険にわたる商品の深さが人口動態シフトに直接対応しています。医療・CI保険料が業界全体で**年率13.7%成長**する中[TLAA 2024]、AIAの保障重視のポジションはこのプールから不均衡に大きなシェアを取り込む構造にあります。

戦略的姿勢

グループとしての資本力が、強化されるRBCとIFRS 17の制度下で長期医療・年金保証を支えます[OIC 2025]。AIAは高齢顧客が好む対面代理店の信頼性に、デジタル引受・保険金支払いへの着実な投資を組み合わせ、市場が再プラットフォーム化する中でシェアを守るポジションを確立しています。

強みと注視点

- **代理店規模**：最大の対面網、シニア顧客獲得において決定的
- **保障重視**：医療・CI注力が人口動態の追い風を受ける
- **資本の厚み**：地域系親会社がRBC / IFRS 17負担を緩和
- **注視**：FWDのデジタルバンカ攻勢；コペイメント説明不足リスク

出典凡例 ・ OIC 2024 = Office of Insurance Commission life-premium filings 2024 ・ OIC 2025 = Office of Insurance Commission 2025 directives (RBC, IFRS 17) ・ TLAA 2024 = Thai Life Assurance Association statistics 2024

KIRA. RESEARCH

Confidential ・ ライセンス読者限定 ・ © 2026 KIRA Research

SECTION 11

規制とコスト抑制の転換

保険委員会（OIC）は持続可能性へ方針を転換した。**2025年3月のコペイメント条項**は、リスクベース資本とIFRS 17とともに、医療コストが上昇する中で損害率の規律と財務健全性を重視する制度への転換を示している。

11.1 コペイメント

11.2 RBC & IFRS 17

11.3 新健康保険標準

11.4 勝者と敗者

成長だけでなく持続可能性に照準を合わせた規制制度

OICの2025年アジェンダ ― コペイメント、リスクベース資本、IFRS 17、ESG ― は、人口動態と医療コストの曲線が急峻化する中での**長期的な支払能力**を明確に意識したものです。早期に価格設定・資本・情報開示を整合させた事業者が、抵抗した事業者を業績で上回ります。

コペイメント：需要側のブレーキ

2025年3月19日以降に締結された個人保険契約に適用されるコペイメント条項[OIC 2025]は、過剰受診を抑制し保険料水準を安定させるため、請求コストを契約者と分担する仕組みです。新健康保険標準（OIC Order 14～15/2564）のもとで整備されており、年率**8～10%の医療インフレ**に対する意図的な措置です[Bangkok Post 2024]。

RBCとIFRS 17

リスクベース資本とIFRS 17は長期保証のコストを明確化します[OIC 2025]。年金保険・終身保険のポートフォリオには透明な資本賦課が課され、厳密な資産負債管理（ALM）と潤沢な親会社資本を持つ事業者が有利になります。

市場参加者への含意

コスト抑制への転換は**規模・保険数理の専門性・顧客への明確なコミュニケーション**を持つ事業者に有利です。コペイメントをうまく説明できる事業者は信頼を守り損害率を防衛しますが、契約者を驚かせた事業者は失効と逆選択のリスクにさらされます。

- **勝者**：強力な保険数理機能を持つ、資本力・医療保障重視のリーダー
- **圧力下**：RBC / IFRS 17のもとで資本が薄い規模の小さな事業者
- **転換点**：信頼を損なわずコペイメントを説明できる販売チャネル
- **新潮流**：比較・価格競争を容易にする標準化商品

OICの2025年包括フレームワークは、新たなグローバルリスクに対する金融システム強化のための13項目のメカニズムを列挙しており[OIC 2025]、ヘッドライン成長ではなくレジリエンスが次のサイクルを定義するという明確なシグナルです。

出典凡例 ・ OIC 2025 = Office of Insurance Commission 2025 industry directives (copayment, RBC, IFRS 17, New Health Standard) ・ Bangkok Post 2024 = Bangkok Post insurer medical-inflation report 2024

テクノロジーはパイロットから引受の中核へ

引受、保険金支払い、不正検知におけるAI活用は、グローバルな業界全体で差別化要因から**業界標準**へと移行しています[InsurTech 2025]。高齢化した顧客ポートフォリオを持つタイの保険会社にとっての目標は、迅速なオンボーディング、損害率の制御、そして信頼できる人的アドバイザーの維持可能なチャネル経済性です。

実験からインフラへ

保険会社とインシュアテックは現在、顧客サービス、引受、保険金支払い、不正予測にわたって機械学習モデルを稼働させています[InsurTech 2025]。2026年までにこれらはもはや競争優位ではなくペースライン能力となり、タイの事業者もコアワークフローへの統合を進めています。

不正検知と損害率管理

AI不正検知は先進的な導入例で**不正請求を最大〜30%削減**しています[InsurTech 2025]。コペイメント制度と組み合わせることで、タイの医療保険会社は医療コスト上昇に対する第2のレバーを持つことになります。

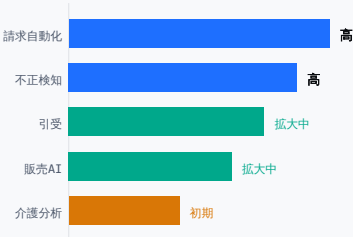
チャネル：補完であり代替ではない

高齢の顧客は依然として対面アドバイスとバンカシュアランスを信頼しています。タイで現実的なのは**AIで強化された代理店・バンカ**というパターンです — デジタルツールが見積もり・引受・保険金支払いを効率化しつつ、人的関係が販売の基盤を担います。

タイ保険業界でのAI活用の優先領域

MATURITY

導入成熟度 ・ 方向性指標



SOURCE: INSURTECH DIGITAL, NORTON ROSE FULBRIGHT ・ KIRA ANALYSIS ・ KIRA RESEARCH 2026

不正請求削減率

〜30 %

先進的AI導入事例 [InsurTech 2025]

INSURTECH

2026年の位置づけ

Table stakes

AI請求・引受 [InsurTech 2025]

INSURTECH

タイの優先チャネル

Banca + 代理店

高齢顧客の信頼チャネル

KIRA EST.

出典凡例 ・ InsurTech 2025 = InsurTech Digital, AI claims & underwriting review 2025 ・ Kira estimates = KIRA in-house analyst triangulation

タイの保険会社を変革する6つのテクノロジー活用事例

実務への落とし込みが2027年の勝者と敗者を分けます。これらの事例は顧客獲得から保険金支払い管理まで幅広く、いずれもタイまたは最も近い地域ベンチマークで現在観察可能なものです。

01 • UNDERWRITING

アルゴリズム健康引受

MLモデルが高齢申込者の医療・CI リスクをより速く、より細かく価格設定し、従来は一律排除されていた引受可能年齢を拡大します。60歳以上の顧客プールを収益的に取り込む上で不可欠です。

BENCHMARK: PAN-ASIAN CARRIERS

02 • CLAIMS

保険金支払いの自動化

AIが定型的な医療請求を手動処理なしに審査・支払い、処理時間とコストを削減します。コペイメントルールと組み合わせることで、一貫性のある監査可能な査定を規模に応じて実施できます。

STATUS: HIGH MATURITY GLOBALLY

03 • FRAUD

保険金不正検知

パターンモデルが異常な医療請求を検出し、先進的な導入例では不正支払いを最大**〜30%削減**しています[InsurTech 2025]。医療コスト上昇に対する直接的な損害率改善レバーです。

ANCHOR: ~30%不正削減

04 • DISTRIBUTION

代理店・バンカ支援

レコメンデーションエンジンがアドバイスの時点で各顧客に最適な年金保険やヘルスライダーを提示し、加齢ライフサイクル全体でクロスセルを向上させながら、信頼できる人的チャネルを維持します。

OBSERVABLE: BANCASSURANCE LEADERS

05 • RETENTION

失効・継続率モデリング

予測モデルが失効リスクの高い契約（コペイメント変更で期待が変わった契約者に多い）を特定し、長期の医療・年金ポートフォリオを守るためのプロアクティブな対応を可能にします。

TIE-IN: コペイメント説明

06 • CARE ANALYTICS

長期介護リスク分析

新興モデルが高齢者の要介護度と介護コスト軌跡を予測 — **THB 5,000億**規模の2040年介護コスト波に対応する介護保険商品の価格設定の基盤となります[NER 2024]。

STAGE: 初期・高い戦略的価値

出典凡例 • InsurTech 2025 = InsurTech Digital, AI claims & underwriting review 2025 • NER 2024 = Development Economic Review, long-term care cost projection 2024

2032年展望：ヘッドライン成長は控えめ、構成転換は決定的

タイの収入保険料成長は**低～中一桁台**で推移すると見ており、人口動態転換がヘルスライダー・年金保険、そしてホライズン後半には介護保険で平均超えの拡大を牽引します。勝者は今から高齢顧客に向けてポジションを再構成する事業者です。

ベースケース

業界収入保険料は**2029年まで約4%で複利成長**[Statista 2025]し、生命保険単体は2028年までに～USD 230億へ[GlobalData 2025]。医療・CI保険は保障格差と医療インフレが続く中[TLAA 2024][GlobalData 2025]、高一桁～低二桁の伸びで市場を上回ります。

上振れ・下振れ要因

上振れ要因：民間医療への中間層の取り込み加速、税制優遇付き年金保険、介護保険商品の革新。下振れ要因：経済減速による保護支出の裁量的縮小、またはコペイメント摩擦が近期のヘルスライダー販売を抑圧するシナリオ。

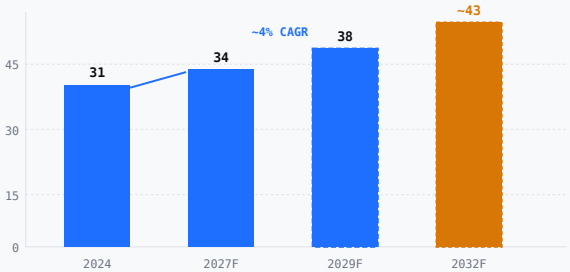
戦略的命題

人口動態の曲線はこの市場で最も信頼性の高い変数です。**60歳以上のライフサイクル向けにポートフォリオを再構成し** — 医療、年金保険、介護 — 資本力強化とAIで強化された販売に投資してください。規模が小さく貯蓄型に傾いた事業者が最も大きな調整を迫られます。

収入保険料合計の軌跡

USD BN

タイ ・ USD BN ・ 2024–2032F



SOURCE: STATISTA, GLOBALDATA ・ 2032 FIGURE KIRA-ESTIMATED FROM ~4% CAGR ・ KIRA RESEARCH 2026

2027年市場（ベースケース）

～34 USD bn

～4% CAGRベース [Kira estimates]

KIRA EST.

生命保険 2028年

23 USD bn

[GlobalData 2025]

GLOBALDATA

介護コスト波 2040年

500 THB bn

要介護高齢者の介護費 [NER 2024]

NER

出典凡例 ・ GlobalData 2025 = GlobalData Thailand life insurance market analysis 2025 ・ NER 2024 = Development Economic Review long-term care projection 2024 ・ Statista 2025 = Statista Thailand insurance forecast 2025 ・ TLAA 2024 = Thai Life Assurance Association statistics 2024 ・ Kira estimates = KIRA in-house analyst triangulation

調査方法論と出典索引

本分析は、規制当局・業界団体の統計、人口動態・医療制度研究、事業者の開示資料を、KIRAアナリストの三角検証と組み合わせています。将来数値は確定予測ではなく、記録済みの基準年に固定した方向性シナリオです。定量的主張の約5分の1はKIRA推計であり、残りは記名外部出典を引用しています。

SOURCE INDEX

[1]

Thai Life Assurance Association — 生命保険料統計・年次報告書 2024年。

[2]

Thai General Insurance Association — 損害保険収入保険料統計 2024年・2025年上半年期。

[3]

Office of Insurance Commission — 2024年收入保険料届出；2025年業界指令、コペイメント条項、RBC・IFRS 17。

[4]

GISTDA — 高齢者と子ども世代の比較に関する2025年人口分析。

[5]

World Health Organization — 東南アジア健康の高齢化特集；2035年超高齢社会予測。

[6]

World Bank — Caring for Thailand's Aging Population；医療費系列データ 2023年。

[7]

Universal Coverage Scheme 利用実態・自己負担調査 2024年。

[8]

Frontiers in Public Health — UCS低利用の規定要因 2024年。

[9]

Development Economic Review — 将来の医療費と長期介護コスト 2024年。

[10]

Statista — タイ保険市場予測 2025年。

[11]

GlobalData — タイ生命保険市場分析・2028年予測 2025年。

[12]

Bangkok Post — 保険会社成長・医療インフレ報道 2024年。

[13]

Muang Thai Life — 年金・老後商品開示 2025年。

[14]

InsurTech Digital — 保険金支払い・引受におけるAI活用 2025年。

[15]

KIRA Research — 上記全出典にわたる社内アナリスト三角検証。